REVISION CASO CLINICO

Viviana Inés Méndez Fandiño
Edward Camilo Vela Vargas

RESIDENTES MEDICINA FAMILIAR

SHARON ACUÑA Ginecologa

DATOS IDENTIFICACION

Nombre Paciente: TORRES RUEDA LAURA CAROLINA
Identificación: TI 1055127841
Fecha Nacimiento: 18/11/2008
Edad Actual: 17 Años / 3 Meses / 12 Días
Estado Civil: Soltero
Dirección: VEREDA PAPAYAL
Sexo: Femenino
Procedencia: MONIQUIRA
EPS: NEPS - Subsidiado
Estrato: 1

CONSULTA EXTERNA (27/12/2025)

MOTIVO DE CONSULTA: “DOLOR BAJITO Y EL UTERO ESTA GRANDE POR UN MIOMA”

ENFERMEDAD ACTUAL :**PACIENTE DE 17 AÑOS**, **G0P0** CON CUADRO CLINICO DE **3 MESES DE EVOLUCION** DE EVIDENCIA DE **DOLOR EN HEMIABDOMEN INFERIOR, ASOCIADO A DOLOR PELVICO DE MODERADA INTENSIDAD, CON EVIDENCIA DE AUMENTO PROGRESIVO DEL TAMAÑO UTERINO, CON EVIDENCIA CON SANGRADO ABUNDANTE, FUR: 08/12/25** CON DURACION DE **9 DIAS, CON EXPULSIÓN DE COAGULOS,**

… POR LO CUAL SE REALIZO **ECOGRAFIA PELVICA TV EXTRAINSITTUCIONA**L DEL **17/12/25** CON EVIDENICA DE UTERO EN AVF, IRREGULAR, CON EVIUDENCIA DE **MIOMA FIGO 2-5 DE 111*108 MM**, **VOLUMEN UTERINO DE 903 CC**.. POR LO CUAL CONSULTA.

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

SOCIEDAD MÉDICA
DE ESPECIALISTAS

ECOGRAFÍA PÉLVICA TRANSVAGINAL

miércoles, 17 de diciembre de 2025
Nombre: LAURA CAROLINA TORRES EDAD: 17 AÑOS

Mediante transductor de 10,0 Mhtz se realiza ecografía pélvica transvaginal, encontrando:

Útero en AVF, de contornos irregulares ecogenicidad heterogeneo, medidas 223 x 106 x 130 mm., Volumen 903 cc., en cuerpo posterior nodulo hipoecogeno que se proyecta a línea media de 111 x 108 mm., correspondiente a mioma FIGO 2-5
Cavidad endometrial homogénea, desplazado de 6.4 mm. de grosor.

Cuello uterino ecograficamente normal de 44 mm. de longitud

Ovario derecho : 35 x 17 x 14 mm. Ecogenicidad Normal.

Ovario izquierdo: 33 x 19 x 15 mm. Ecogenicidad Normal.

Anexos : Normales

Fondo de saco de Douglas libre.

OPINION : MIOMA UTERINO FIGO 2-5 GIGANTE .

ANTECEDENTES

PATOLÓGICOS: NIEGA

QUIRÚRGICOS: REDUCCION DE FX DE MUÑECA DERECHA FARMACOLÓGICOS: GESTAVID

ALÉRGICOS: NIEGA

HOSPITALARIOS: NIEGA

TÓXICO: NIEGA CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS, CIGARRILLO O LICOR FAMILIARES: NIEGA HISTORIA DE CÁNCER HEREDOFAMILIAR NIEGA TRANSFUSIONALES: NIEGA

TRAUMÁTICOS: NIEGA

GINECOLÓGICOS: MENARQUIA: 13

COMPAÑEROS SEXUALES: 1 INICIO DE VIDA SEXUAL: 17 CICLOS: REGULAR 30*5 MÉTODO ANTICONCEPTIVO PREVIO: PRESEVATIVO

EXAMEN FÍSICO (27/12/2025)

SIGNOS VITALES: TA: 80/60, **FC**:74, **T°:** 36, **PESO:** 55,80 **I.M.C.**: 23,23.

ABDOMEN: BLANDO, GLOBOSO ASOCIADO A AUMENTO DE TAMAÑO UTERINO, CON FONDO UTERINO QUE SE ENCUENTRA A 18 CM DE LA SINFISIS DEL PUBIS, CON SENSACION DE MASA INDURADA, NO APARENTA ADHERIDA A PLANOS PROFUNDOS, SIN DOLOR A LA PALPACION, SIN SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL, **PELVIS**: GENITOURINARIO: NO SE RELIZA TACTO VAGINAL, **EXTREMIDADES:** SIMETRICAS MOVILES SIN EDEMAS, **NEUROLOGICO:** SIN DEFICIT

DIGNOSTICO: MASAS UTERINA GIGANTE - POSIBLE MIOMA FIGO 2-5

PLAN: RESONANCIA PELVICA CON CONTRASTE V** PRIORITARIA SS CREATININA CONTROL CON GINECOLOGIA CON RESULTADOS

INGRESO DE URGENCIAS OBSTETRICAS(13/01/2026)

ENFERMEAD ACTUAL

PACIENTE 17 AÑOS G0 CON ANTECEDENE DE MIOMATOSIS UTERINA GIGANTE QUIEN INGRESA CON CUADRO CLINICO DE 20 DIAS DE EVOLUCIÓN CONSISTENTE EN **SANGRADO VAGINAL INTERMITENTE DE COLORACIÓN ROJIZA RUTILANTE CON COAGULOS, ASOCIADO ASTENIA, ADINAMIA, PALIDEZ MUCOCUTANEA, EMESIS DE 3 EPISODIOS DE CONTENIDO ALIMENTICIO CON LIPOTIMIA DEL DIA DE AYER**. SE REALIZO ECOGRAFIA PELVICA TV EXTRAINSITTUCIONAL DEL 17/12/25 CON EVIDENICA DE UTERO EN AVF, IRREGULAR, CON EVIUDENCIA DE MIOMA FIGO 2-5 DE 111*108 MM, VOLUMEN UTERINO DE 903 CC. NIEGA DEMAS SINTOMATOLOGIA

EXAMEN FÍSICO (13/01/2026)

TA: 111/77, **SPO2**: 95%, E**STADO DE CONCIENCIA** ALERTA, **PESO** 54 **IMC** 21.36, **FR** 15, **FC** 84, **TEMP** 36, **Glasgow: 15/15**

ABDOMEN: BLANDO DEPRESIBLE, CON MASA PALPABLE HASTA NIVEL UMBULICAL, DE CONSITENCIA DURA, LEVEMENTE DOLOROSA, NO MOVIL, SIN SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL

GENITOURINARIO: GENITALES NOMOCNJUGADOS, TACTO VAGINAL CON VAGNINA NT/NE CON CUALLO OSTERIOR LARGO CERRADO, CON IMPRESIÓN DE UTERO AUMENTADO DE TAMAÑO HASTA NIVEL UMBILICAL, NO SE PALPAN MASAS ANEXIALES, CON ESTIGMAS DE SANGRADOS, SIN SANGRADO ACTIVO

PLAN: OBSERVACIÓN DE GINECOLOGIA (PARACETAMOL Y LEV)

SOLICITUD: TP, PTT, HEMOGRAMA: EN LIMITES NORMALES**, BETA HCG**: NEGATIVA

CONSULTA EXTERNA (19/02/2026)

MOTIVO DE CONSULTA:"**YA TENEMOS LA RESONANCIA "**

ENFERMEDAD ACTUAL:

PACIENTE DE 17 AÑOS, G0P0 CON MIOMA GIGANTE, ACUDE EN COMPAÑIA DE SU MADRE, CON REPORTE DE RMN DE PELVIS CON CONTRASTE, REFIERE DESDE APROX 3 MESES DOLOR EN HEMIABDOMEN INFERIOR, ASOCAIDO A DOLOR PELVICO DE MODERADA INTENSIDAD, CON SENSACION DE MASA ABDOMINAL. ADEMAS REFIERE SANGRADO MESNTRUAL ANORMAL DADO POR AUMENTO DE VOLUMEN LOS PRIMEROS 5 DIAS CON MANCHADO PÈRSISTENTE HASTA 30 DIAS.

VIDA SEXUAL ACTIVA, PLANIFICACION ACOS, FUR HACE 30 DIAS. REFIERE HA CONSULTADO A URGENCIAS 1 OCASIÓN POR HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL, ADEMAS REFIERE **CON ACO HA DISMINUIDO LEVEMENTE EL VOLUMEN DE SANGRADO**, SIN EMBARGO PERSISTE MANCHADOS PROLONGADOS Y DOLOR PELVICO

ANALISIS

PACIENTE DE 17 AÑOS, G0P0 CON MIOMA GIGANTE… REFIERE CON ACO HA DISMINUIDO LEVEMENTE EL VOLUMEN DE SANGRADO, SIN EMBARGO PERSISTE MANCHADOS PROLONGADOS Y DOLOR PELVICO

…CON ABDOMEN GLOBOSO POR UTERO AUMENTADO DE TAMAÑO HASTA 3 CM POR ENCIMA DE NIVEL UMBILICAL DESDE EL PUBIS, APROX 20 CM, CON LEVE DOLOR A PALPACION, SIN IRRITACION PERITOENAL, MASA INDURADA, NO APARENTA ADHERIDA A PLANOS PROFUNDOS

PACIENTE CON MIOMATOSIS UTERINA CON MIOMATOSIS UTERINA CONFIRMADA POR RMN DE PELVIS CONTRASTE DE 135 x 139 x 87 mm. LOCALIZACION PREDOMINIIO MURAL PARCIALMENTE SUBSEROSO, SIN COMPROMETER ENDOMETRIO.

RESONANCIA MAGNÉTICA DE PELVIS CON CONTRASTE 10/02/202

Útero aumentado de tamaño con presencia de imagen redondeada, de predominio hipointenso en T2, que presenta realce homogéneo con el medio de contraste; de localización **predominio mural parcialmente subserosa, contacta el endometrio desplazándolo hacia posterior e inferior sin comprometerlo, mide 135 x 139 x 87 mm.**

Útero de forma, tamaño e intensidad de señal conservada. Cavidad endometrial vacía, con endometrio homogéneo en todas las secuencias. No se identifican lesiones focales o difusas. Los ovarios conservan, forma, tamaño e intensidad de señal usual para la edad. No hay líquido libre en el fondo de saco. No se identifican adenomegalias en las cadenas ilíacas o en regiones inguinales. La vejiga distiende adecuadamente, de paredes delgadas y contenido homogéneo en todas las secuencias. Lo visualizado de la fascia y grasa mesorectal es normal.

Las relaciones articulares coxofemorales, de la sínfisis del pubis y las sacroilíacas no presentan alteraciones significativas para señalar. La intensidad de señal de la medular ósea se encuentra conservada en todas las secuencias. Planos grasos y musculares sin alteración. **CONCLUSIÓN: MIOMA FIGO 2-5**

- Acetato de Leuprolide 45 mg
- Ulipristal acetato 30 mg

OPCIONES PARA TRATAMIENTO-FIBROMA DEL UTERO

Type	Option
Non-hormonal	
	Tranexamic acid
Hormonal	
	Progestins • Levonorgestrel-releasing intrauterine systems • Oral progestins
	Combined oral contraceptives
	Gonadotropin-releasing hormone analogs • Gonadotropin-releasing hormone agonists • Gonadotropin-releasing hormone antagonists
	Progesterone-receptor modulators

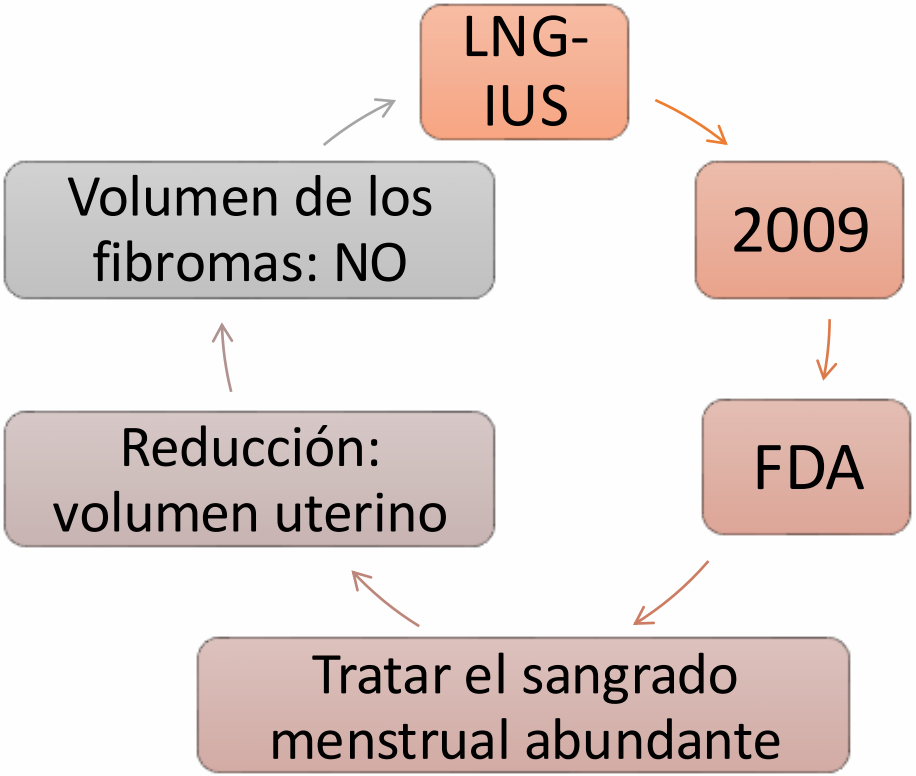
ACIDO TRANEXAMICO

ACIDO TRANEXAMICO

ANTRIFINOLITICO SINTETICO ANALOGO DE LISINA

AYUDA A MANEJAR EL SANGRADO PERO NO AFECTA EL TAMAÑO

SISTEMA INTRAUTERINO LIBERADOR DE LEVONOGESTREL(LNG-IUS)



Sistémicas: progestágenos orales.

Ovulación y la esteroidogénes ovárica.

Producción de

Estimulación dependiente del estrógeno del endometrio

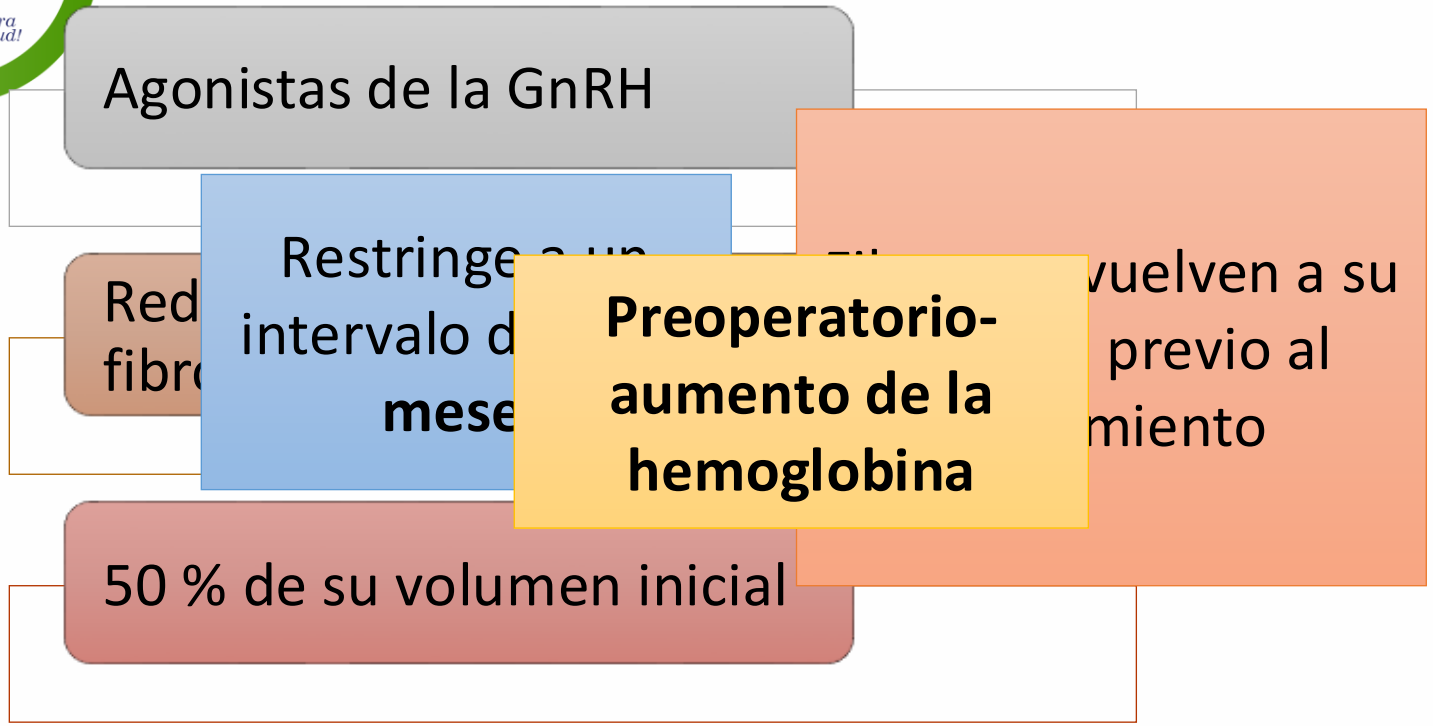
Sangrado menstrual abundante- Anticoncepcion

En

educen el nen de los ibromas.

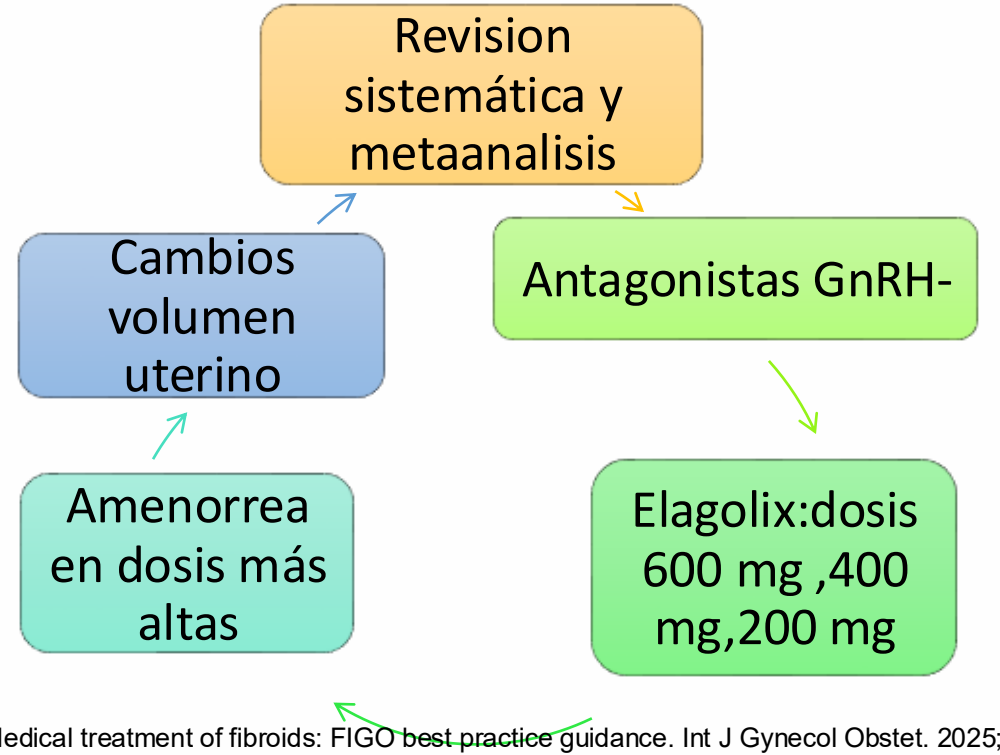
Díaz I, Lumsden MA, Zeppernick M. Medical treatment of fibroids: FIGO best practice guidance. Int J Gynecol Obstet. 2025;171:507-512. doi:10.1002/ijgo.70497.

Análogos de la hormona liberadora de gonadotropina



Díaz I, Lumsden MA, Zeppernick M. Medical treatment of fibroids: FIGO best practice guidance. Int J Gynecol Obstet. 2025;171:507-512. doi:10.1002/ijgo.70497.

Antagonista de la hormona de la hormona liberadora de Gonadotropina



Díaz I, Lumsden MA, Zeppernick M. Medical treatment of fibroids: FIGO best practice guidance. Int J Gynecol Obstet. 2025;171:507-512. doi:10.1002/ijgo.70497.

2019

Antagonista relugolix:40 mg

Agonista leuprolide:dosis inyectable mensual 1.88 mg o 3.75 mg

Reducción del tamaño de los fibromas volumen uterino aumento niveles de hemoglobina

Díaz I, Lumsden MA, Zeppernick M. Medical treatment of fibroids: FIGO best practice guidance. Int J Gynecol Obstet. 2025;171:507-512. doi:10.1002/ijgo.70497.

Moduladores del Receptor de Progesterona

- **Moduladores Selectivos del receptor de progesterona:** reduce el crecimiento fibromas y mejora los sintomas

Revisión Cochrane y un metaanálisis

Estudios PEARL:Controlar eficazmente el sangrado excesivo causado por los fibromas uterinos y reducir el tamaño de estos

vedad de los síntomas

dad de vida

érdida de sangre l y aumentar las tasas de amenorrea

Díaz I, Lumsden MA, Zeppernick M. Medical treatment of fibroids: FIGO best practice guidance. Int J Gynecol Obstet. 2025;171:507-512. doi:10.1002/ijgo.70497.

Long-term medical m… of uterine fibroi… with u…

Jacques Donnez, M.D.,[a] Olivier Donnez, …
Robert Hudecek, M.D.,[e] Janos Zatik, M.D…
Hervé Fernandez, M.D.,[l] David H. Barlow…
Elke Bestel, M.D.,[m] and Ernest Loumaye,…

[a] Société de Recherche pour l'Infertilité, Brus… Catholique de Louvain, Brussels, Belgium; [c] M… für Frauenheilkunde, Klinische Forschung ur… Gynaecology, Masaryk University and Uni… Nogyogyaszati es Ultrahang Maganrendelo, … Medical EUROMED SRL, Obstetrica-Ginecolo… Obstétrique, Le Kremlin-Bicêtre, France; [l] H… United Kingdom; [k] Service d'Endocrinolog… Medicine and Gynecology, University Medica… Geneva, Switzerland; and [n] ObsEva S.A, Plan-…

Objective: To investigate the efficacy and s… treatment of symptomatic uterine fibroids.
Design: Double-blind, randomized administ…
Setting: Gynecology centers.
Patient(s): Four hundred fifty-one subjects …
Intervention(s): Four repeated 12-week trea…
Main Outcome Measure(s): Endometrial sa… volume, quality of life (QoL), and pain.
Result(s): Efficacy results, such as bleedin… Pain and QoL showed marked improveme… ulipristal acetate was confirmed, and repeated treatment courses did not increase the occurrence of adverse reactions. There were no significant changes in laboratory parameters during the study. The percentage of subjects with endometrial thickness ≥16 mm was 7.4% (all subjects) after the first treatment course and returned to below screening levels (4.9%) in subsequent treatment courses. As in previous studies, ulipristal acetate did not increase the occurrence of endometrial features of concern. The frequency of nonphysiological changes did not increase with repeated treatment. They were

Am… **contr…** co… mayor… u…

Reducción del volumen de los fibromas y **disminución del dolor**, lo que se tradujo en una **mejora** clínicamente significativa **de la calidad de vida.**

…ue …da

… la eficacia y …cursos repetidos …**as** de **5 o 10 mg** …tato de ulipristal …ratamiento … de los fibromas …intomáticos

Ulipristal acetate compared with leuprorelin acetate for Japanese women with symptomatic uterine fibroids: a phase III randomized controlled trial

Yutaka Osuga, M.D., Ph.D.,[a] Yasuaki Nakano, M.P
and Masaya Takanashi, M.Pharm.[b]

[a] Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty
Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japan

Objective: To evaluate the efficacy and safety of ulipris
leuprorelin (LEU) as a comparator. This is the first confi
Design: Multicenter, randomized, double-blind, double
Setting: Thirty-two sites in Japan.
Patient(s): Patients were assigned to 2 arms, with 82 p
Intervention(s): In the UPA group, 10 mg of UPA was
mg of LEU was subcutaneously administered at weeks
Main Outcome Measure(s): The primary endpoint was the pe
adverse events (AEs) were recorded.
Result(s): The percentage of patients with amenorrhea for 35 da
efficacy of UPA for causing amenorrhea for 35 days was confirmed
tients in the UPA group and 88.8% of the patients in the LEU group.
Conclusion(s): The effect of UPA on heavy menstrual bleeding was shown to be comparable with that of LEU in Japanese patients with symptomatic UFs. No notable AEs occurred because of the UPA treatment, and the incidence of AEs in the UPA group was comparable with that of AEs in the LEU group. This result demonstrates the clinical utility of UPA for Asians. (Fertil Steril® 2021;116:189–97. ©2021 by American Society for Reproductive Medicine.)
El resumen está disponible en Español al final del artículo.

Key Words: Leiomyoma, menorrhagia, selective progesterone receptor modulator, ulipristal acetate, uterine fibroids

Discuss: You can discuss this article with its authors and other readers at https://www.fertstertdialog.com/posts/31400

Se demostró que el efecto de la UPA sobre el sangrado menstrual abundante era comparable al de la LEU en pacientes japonesas conUF sintomáticas

r la eficacia y la
del acetato de
UPA) para los
terinos (FU), se
n estudio de fase
relina (LEU) como
Este es el primer
ensayo confirmatorio **del UPA para los FU entre asiáticos**.

Osuga Y, Nakano Y, Yamauchi Y, Takanashi M. Ulipristal acetate compared with leuprorelin acetate for Japanese women with symptomatic uterine fibroids: a phase III randomized controlled trial. Fertil Steril. 2021;116(1):189-197. doi:10.1016/j.fertnstert.2021.01.023.

Ulipristal Acetate and Fibroids

Ulipristal acetate for uterine fibroids: a systematic review and meta-analysis

Theodoros Kalampokas, Mohan Kamath, Ioannis Boutas & Emmanouil Kalampokas

Pages 91-96 | Received 22 May 2015, Accepted 07 Oct 2015, Published online: 16 Nov 2015

Cite this article https://doi.org/10.3109/09513590.2015.1106471 Check for updates

Los resultados incluyeron **alivio de los sínf**
parámetros relacion
la **calidad de v**
reducción del tan
los **fibromas**, ef
secundarios y **tasa de recurrencia.**

4 ensayos controlados
torizados

aro Ulipristol
Placebo

aro Ulipristol
vs Analogos Hormona liberado de Gonadotropina

Aumento de los cambios **no fisiológicos** relacionados con el **endometrio tras la AU**